

CD73210605EFB
H36907121248D

INDICADO POR: Dr. Camo
ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 537161971C9B2

MARGARIDA DOS SANTOS

IDADE: 76a PESO: 83 ALTURA: 160 PROFISSÃO: *nova Sozenha, Santa Branca*
SINTOMAS: HAS,

QUEIXAS: Dorco; sonolência Exame; dor Coluna/pelvis; Angioplastia

MEDICAMENTOS:

MÉDICO: Dr. Camo (Cardio)

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h30 23h HORA QUE ACORDA: 8h 7h30

COCHILLO () S () N 3h DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE: 1x ou 2x.

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 50,8 e/h SPO2: 86%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA *joelho* () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRRAFIA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

21/03/2025 *Adaptação - 1º exame*

05/04/2025 *Início Adaptação - Auto 4º doctmto* *marc Camo (M)*

12/04/25 P=8cmH2O
IAH=2,8 e/h *Oriento ajuste de máscara e higiene do sono*
m de uso: 7h56'

Natacha

26/04/25 P=8cmH2O
IAH=2,4 e/h *Bem adaptada*
m de uso: 7h55' *Natacha*

05/05 P= 8,0 cm H₂O
2025 IAH= 2,3 x 1h
muro= 6h30 min
fuga=

A 2/2 temp/umid.
APE deslig
smart acampa / 5 min 4m H₂O
tipo marc x1
complete Phillips

Silvia

05/07 P= 8,0 cm H₂O
25 IAH= 2,1 e 1h
m de uso: 7h32'
fuga= 0,0 e pu

1x ao banheiro

encaminhamento p/ Dr. Cassio

Sua claudia

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: MARGARIDA DOS SANTOS

Data do Exame: 16-12-2024

Peso: 83 kg

Médico Solicitante: DR. JOSE CASSIO DE ABREU

Sexo: Feminino

Idade: 75 anos

Altura: 1,60 m

Neurologia
Dr. RIDGER
ARAUZ

3922-205
3245
(12) 39 210701

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 16/12/2024 20:59 e finalizado às 17/12/2024 05:41.
A latência para início do sono foi de **98,0 min** e a latência para o sono REM de **131,5 min**.
O tempo total de sono (TTS) foi de 349,5 min, com eficiência do sono de **67,0 %**.
A distribuição dos estágios do sono mostrou **4,1 %** de estágio N1, **54,2 %** de estágio N2, **10,7 %** de estágio N3 e **30,9 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 74,4 min. Ocorreram 45 despertares, sendo o índice de **5,2 (nº/h)**.
O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.
O número total de eventos respiratórios foi de 296, sendo 132 apneias obstrutivas, 1 apneias centrais, 0 apneias mistas, 163 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **50,8 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 42,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 54,4. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 50,8 (nº/h), sendo 22,8 apneia/h e 28,0 hipopneia/h.
A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 95%, a média de 95% e a mínima de 86%.
O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 13,7 (nº/h), sendo que em REM foi de 21,1 (nº/h) e em NREM foi de 19,4 (nº/h). Permaneceu 0,1 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

- Índice de distúrbio respiratório (**50,8 nº/h**) acentuadamente elevado predominando os eventos respiratórios obstrutivos (VN= até 5 nº/h);
- Presença de dessaturação da oxi-hemoglobina associado aos eventos respiratórios anormais;
- Aumento da latência para o início do sono (**98,0 min**) (VN= até 30 min)
- Aumento da latência para o início do sono REM (**131,5 min**) (VN= 70 a 120 min)
- Eficiência do sono diminuída (**67,0 %**) (VN= ≥ 85%);
- Índice de despertares normal **5,2 nº/h** (VN= até 15 nº/h);
- Percentual do estágio N1 normal (**4,1 %**) (VN= 2% a 5%);
- Percentual do estágio N2 normal (**54,2 %**) (VN= 45% a 55%);
- Diminuição do percentual do estágio N3 ondas delta (**10,7 %**) (VN= 13% a 23%);
- Aumento do percentual do estágio REM (**30,9 %**) (VN= 20% a 25%).
- Ronco constante verificado via sensor de ronco durante a leitura do exame;

CPAP

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5 h normal, de 5 a 15 h leve, de 15 a 30 h moderado e acima de 30 h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1 h normal, de 1 a 5 h leve, de 5 a 10 h moderado e acima de 10 h elevado.

Nome: MARGARIDA DOS SANTOS

Data do Exame: 16-12-2024

pág. 1